

Centre Médical Sommeil SomnoGalien

16, Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél: 01 61 12 90 43

Dr Gabriel ROISMAN

PNEUMOLOGUE - Praticien Hospitalier
Chef de l'U.F. de Somnologie et des EFM
Hôpital Antoine Bécère
Conventionné Secteur 2
RPPS : 10004426796

À : Dr. Célia FOURNIER - Médecin généraliste
4 Rue de la Princesse de Clèves, 78280
GUYANCOURT

Le 19 janv. 2026

Cher confrère,

J'ai bien reçu M. Xavier BOUBERT, né le 03/03/1986 (39 ans), le 19/01/2026.

Contexte clinique :

Apnées observées, ronflement, étouffements en dormant, impatiences. Asperger, contexte anxiodépressif. Exposition aux écrans avant l'endormissement. Traitement par PAROXETINE, ALPRAZOLAN si besoin.

Echelle de somnolence - Epworth : 14

Index de sévérité de l'insomnie - ISI : 20

Echelle de Beck : 7

Périmètre du cou : 47 cm

Mallampati : III

Voile du palais bas

Rétrognathie : non

Polysomnographie :

-Mauvaise qualité subjective du sommeil cette nuit. -Le temps de sommeil est de 7 heures et 5 minutes. - Endormissement en stade N1 à 10 min de l'extinction de la lumière. -Sommeil de qualité médiocre, d'efficacité diminuée et très fragmenté par la présence de nombreux micro-éveils (61/h) et 55 éveils intra sommeil dont la durée cumulée est de 68 minutes. -La fragmentation du sommeil est liée essentiellement aux anomalies respiratoires. -Déficit en sommeil lent profond et en sommeil paradoxal. -Présence de quelques rares mouvements périodiques des jambes éveillants et indépendants des anomalies respiratoires (15/h). -Le ronflement occupe 80% du temps de sommeil et son énergie moyenne est de 90 db. -L'analyse de la respiration met en évidence des événements apnéiques éveillants et désaturants, dont le mécanisme prédominant est obstructif (IAH : 35/h). -La charge hypoxique est modérée: 61%/min/h. -Absence d'influence positionnelle significative sur la survenue des anomalies respiratoires.

Conclusion :

- SAOS sévère
- Perte de poids souhaitable
- Prescription de PPC

Bien confraternellement,

Signé via Doctolib le 19/01/2026
Gabriel ROISMAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriel Roisman', enclosed within a blue rectangular box.

Centre Médical Sommeil SomnoGalien

16, avenue Morane Saulnier - 78140 Vélizy-Villacoublay

EXAMEN DE POLYSOMNOGRAPHIE

Nom : BOUBERT Prénom : XAVIER Né(e) le : 03-03-1986
Taille: 177 cm Poids : 104 kg Indice corporel : 33 Kg/m²
Dossier : boub10305rai Date d'enregistrement : 29-10-2025
Durée : 8h47min Durée validée :8h9min
Polysomnographie réalisée avec un appareil Cidelec :CID-LXe NS:23797
Examen réalisé par : GUITOGER CAROLE (technicien sommeil)
Médecin prescripteur : Dr ROISMAN GABRIEL

INDICATION

Apnées observées, ronflement, étouffements en dormant, impatiences. Asperger, contexte anxiodépressif. Exposition aux écrans avant l'endormissement. Traitement par PAROXETINE, ALPRAZOLAN si besoin.
Echelle de somnolence - Epworth : 14
Index de sévérité de l'insomnie - ISI : 20
Echelle de Beck : 7
Périmètre du cou : 47 cm
Mallampati : III
Voile du palais bas
Rétrognathie : non

ANALYSE DU SOMMEIL

Temps passé au lit : 8 h 25 min
Temps de Sommeil Total : 7 h 5 min (soit une efficacité TST/TIB : 84%)
Latence d'endormissement : 10 min
Latence du stade N1 : endormissement
Latence du stade N2 : 2 min
Latence du stade N3 : 114 min
Latence du sommeil paradoxal : 220 min

STADES	N1	N2	N3	SP
Durée totale (mn)	27	309	58	30
% TST	6.5	72.7	13.6	7.2
Durée validée (mn)	27	293	58	30

Nombre total de micro-éveils : 435 soit 61 par heure
Nombre d'éveils intrasommeil (> 30 s) : 55 (durée totale 68 min)
Nombre d'entrées en stade : 143

EVENEMENTS RESPIRATOIRES

Nombre d'apnées (/TST validé) : 197 soit 29 par heure (dont **145 obstructives, 29 centrales, 23 mixtes**)
Durée cumulée : 49 minutes soit 12% du TST
Durée moyenne : 14 secondes
Durée maximale : 33 secondes
Nombre total d'hypopnées (/TST validé) : 40 soit 6 par heure (dont **40 obstructives**)
Nombre d'hypopnées avec désaturation : 32
Nombre d'hypopnées avec micro-éveil : 29
Index de MELER (ou ERIM ou RERA): 91 soit 13 par heure
Respiration de Cheyne-Stokes (% du TST) : 0.0

APNEES	Stades			
	N1	N2	N3	SP
Nombre	15	168	0	14
Durée totale (min)/ moyenne (sec)/ max (sec)	4/14/23	42/14/33	0/0/0	3/14/20
Index / stade	33	34	0	28
HYPOPNEES				
Nombre	2	35	0	3
Index d'hypopnée	4	7	0	6

SYNTHESE

Index d'apnées hypopnées : **35 par heure**
Index d'apnées, hypopnées + MELER/ERIM : **48 par heure**
Index d'apnées, hypopnées + événements (diminutions) : 48 par heure
Index de micro-éveils en relation avec un événement respiratoire : 36 par heure
Index d'apnées, hypopnées en position dorsale : 49 par heure

APNEES/HYPOPNEES	Stades			
	N1	N2	N3	SP
Index d'apnées hypopnées	37	42	0	33

RONFLEMENTS

Nombre total : 5003 soit 733 par heure
Durée cumulée : 330 minutes soit 80 % du TST
Energie moyenne : 90 db

SATURATION

Nombre de désaturations : 200 soit 29 par heure (seuil de 3%, amplitude moyenne 4.6 %).
Saturation minimale, moyenne, d'éveil : 86%, 95%, 95%
Pourcentage de temps passé à SpO2 < 90% : 1% (0h4min)
Pourcentage de temps passé à SpO2 < 85% : 0% (0h0min)
Pourcentage de temps passé à SpO2 < 80% : 0% (0h0min)
Charge Hypoxique : **61 %min/heure**

DESATURATIONS	Stades			
	N1	N2	N3	SP
SpO2 Moyenne %	96	95	95	95
SpO2 Minimale %	90	86	93	92

PARAMETRES CARDIO-VASCULAIRES

Fréquence moyenne du pouls : 67 cycles/min (écart type : 5.9 cycles/min)
Fréquences minimale / maximale : 49 / 97 cycles/min
Retard moyen fin apnée - fin désaturation : 18 secondes

MOUVEMENTS PERIODIQUES DE JAMBES

Nombre de mouvements périodiques de jambes (éveil, sommeil) : 336 soit 40 par heure
Nombre de mouvements périodiques de jambes (sommeil) : 222 soit 31 par heure
Nombre de micro-éveils en relation avec des mouvements périodiques de jambes : 108 soit 15 par heure

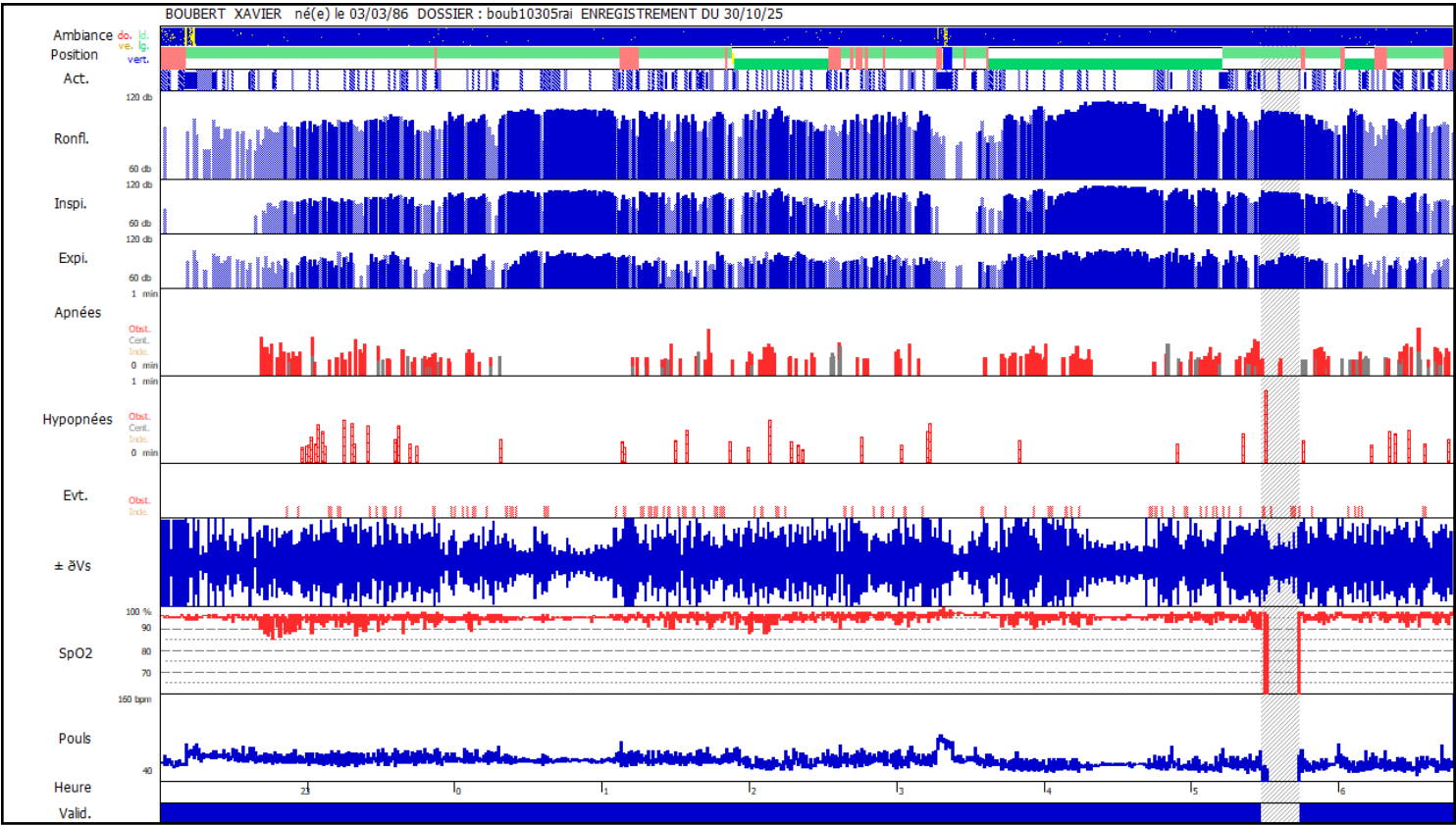
ANALYSE DU SOMMEIL

- Mauvaise qualité subjective du sommeil cette nuit.
- Le temps de sommeil est de 7 heures et 5 minutes.
- Endormissement en stade N1 à 10 min de l'extinction de la lumière.
- Sommeil de qualité médiocre, d'efficacité diminuée et très fragmenté par la présence de nombreux micro-éveils (61/h) et 55 éveils intra sommeil dont la durée cumulée est de 68 minutes.
- La fragmentation du sommeil est liée essentiellement aux anomalies respiratoires.
- Déficit en sommeil lent profond et en sommeil paradoxal.
- Présence de quelques rares mouvements périodiques des jambes éveillants et indépendants des anomalies respiratoires (15/h).
- Le ronflement occupe 80% du temps de sommeil et son énergie moyenne est de 90 db.
- L'analyse de la respiration met en évidence des événements apnéiques éveillants et désaturants, dont le mécanisme prédominant est obstructif (IAH : 35/h).
- La charge hypoxique est modérée: 61%/min/h.
- Absence d'influence positionnelle significative sur la survenue des anomalies respiratoires.

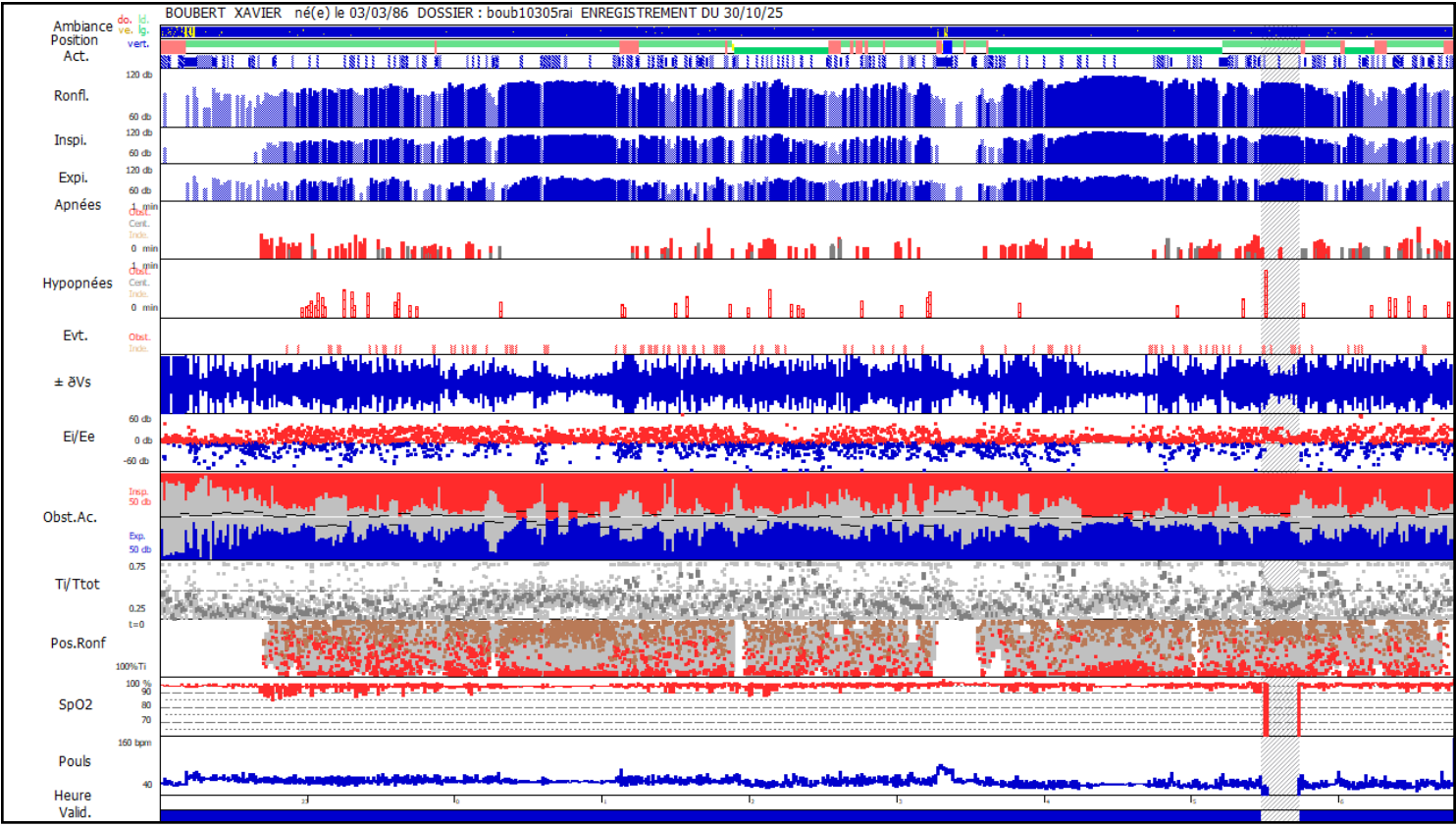
CONCLUSION

SAOS sévère

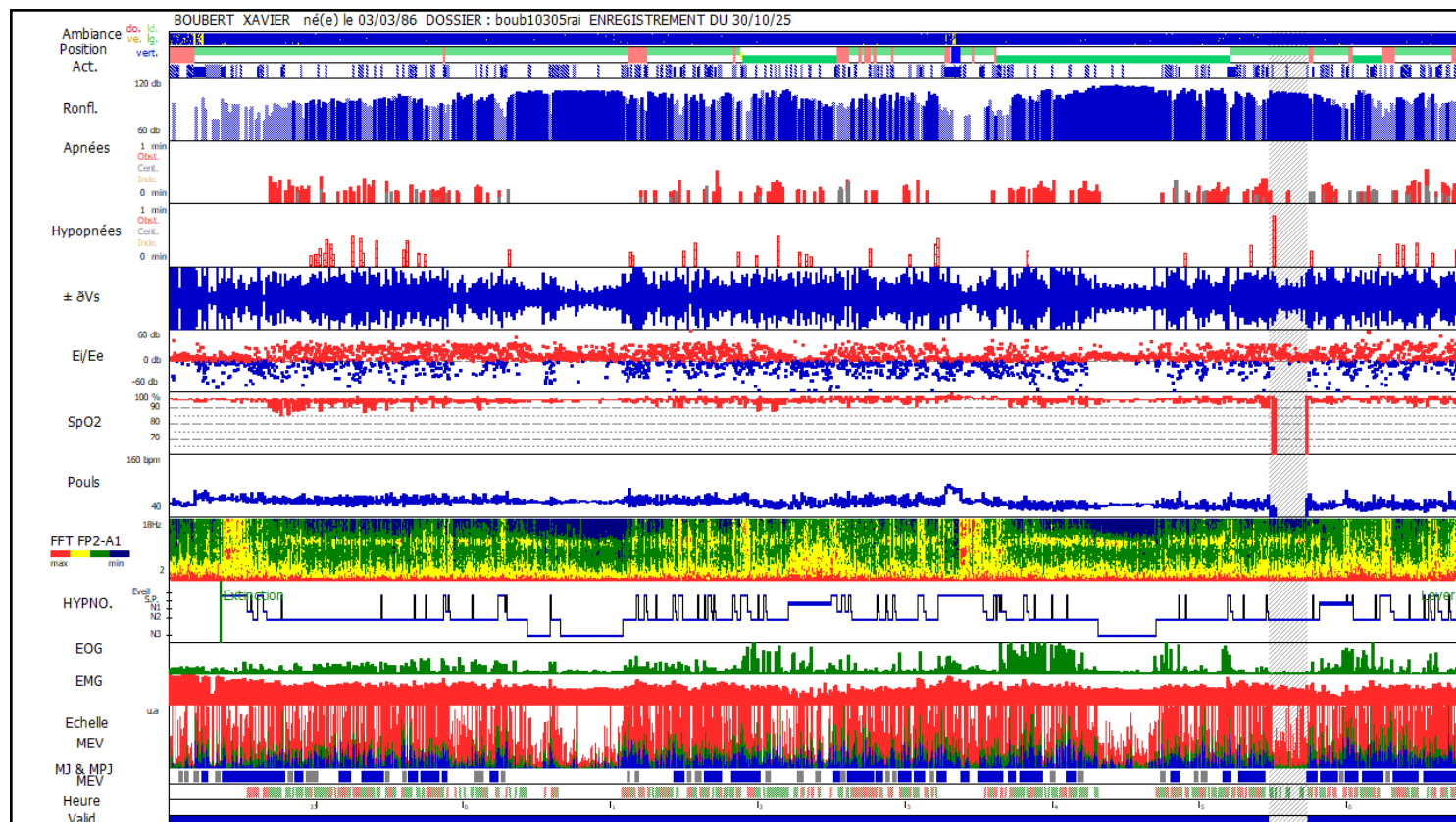
Dr Gabriel ROISMAN



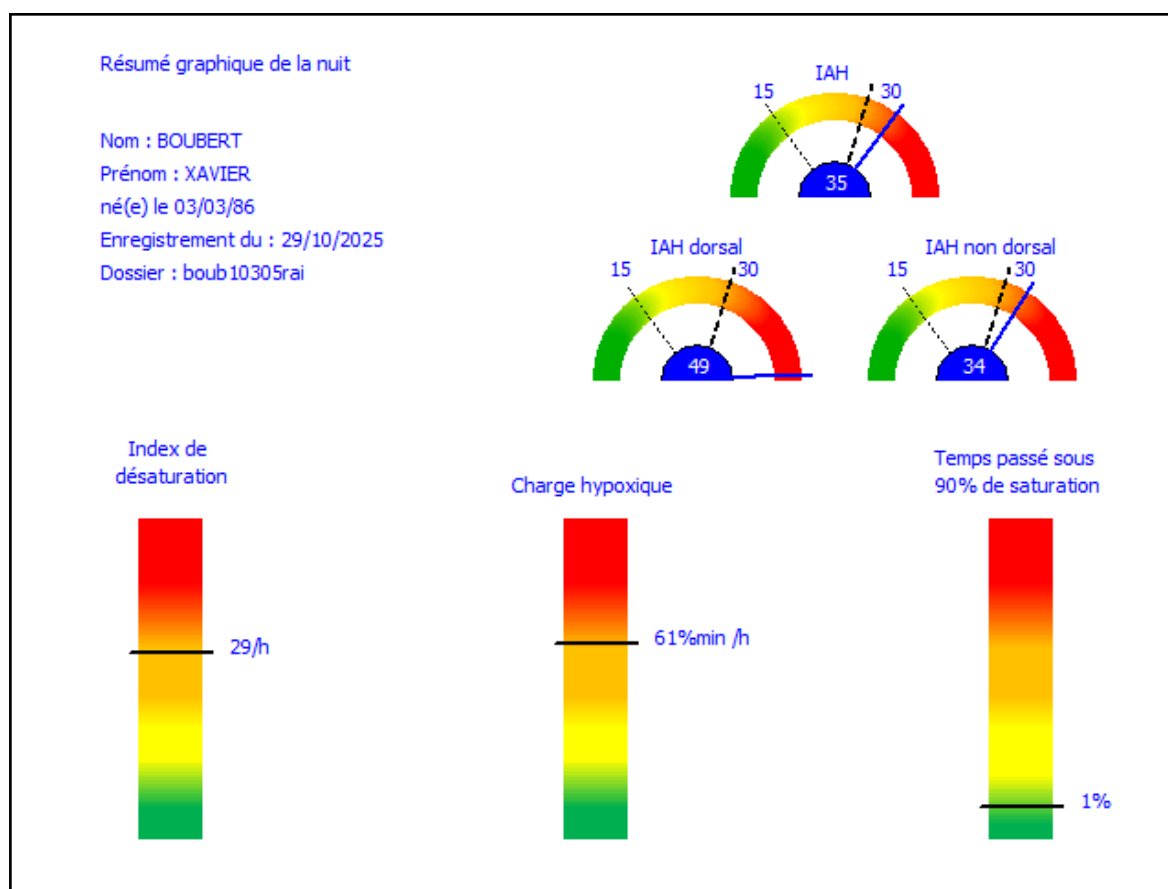
Résumé de l'enregistrement



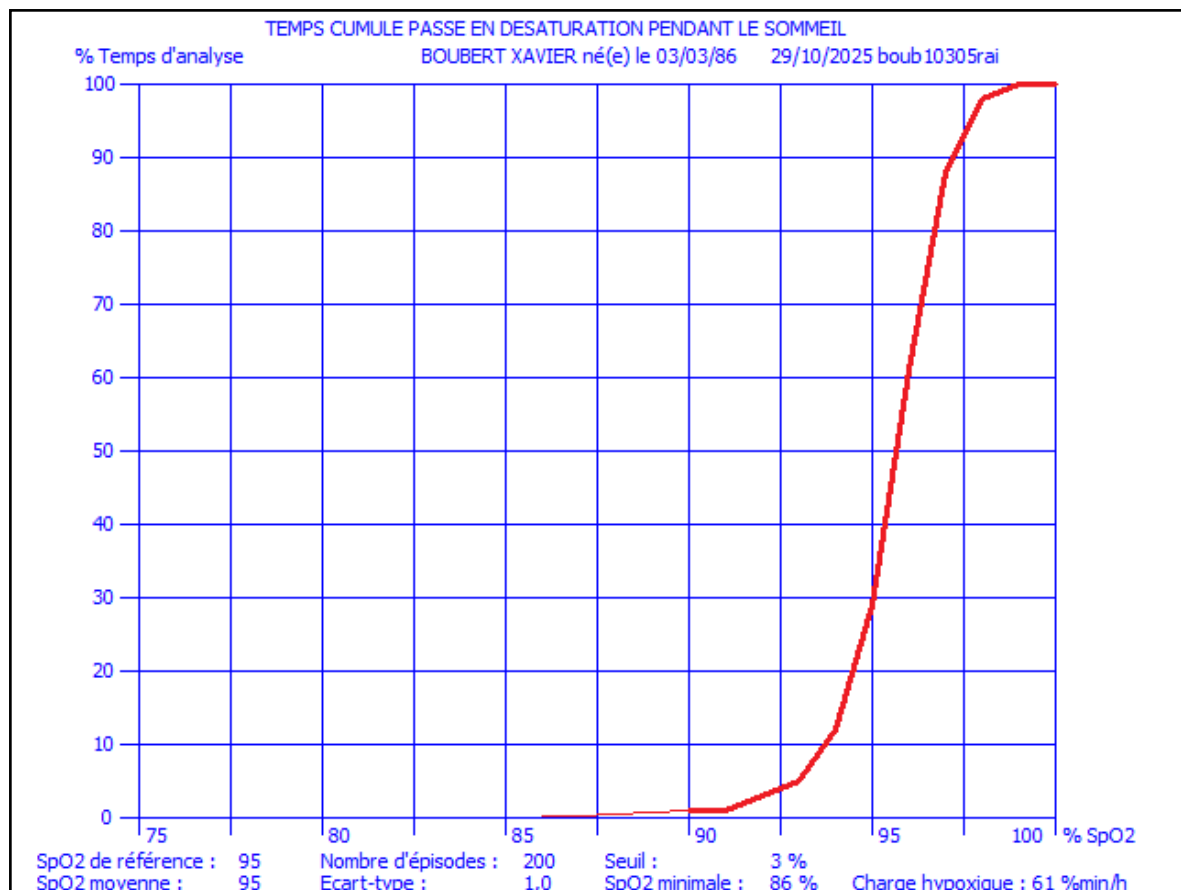
Résumé de l'enregistrement



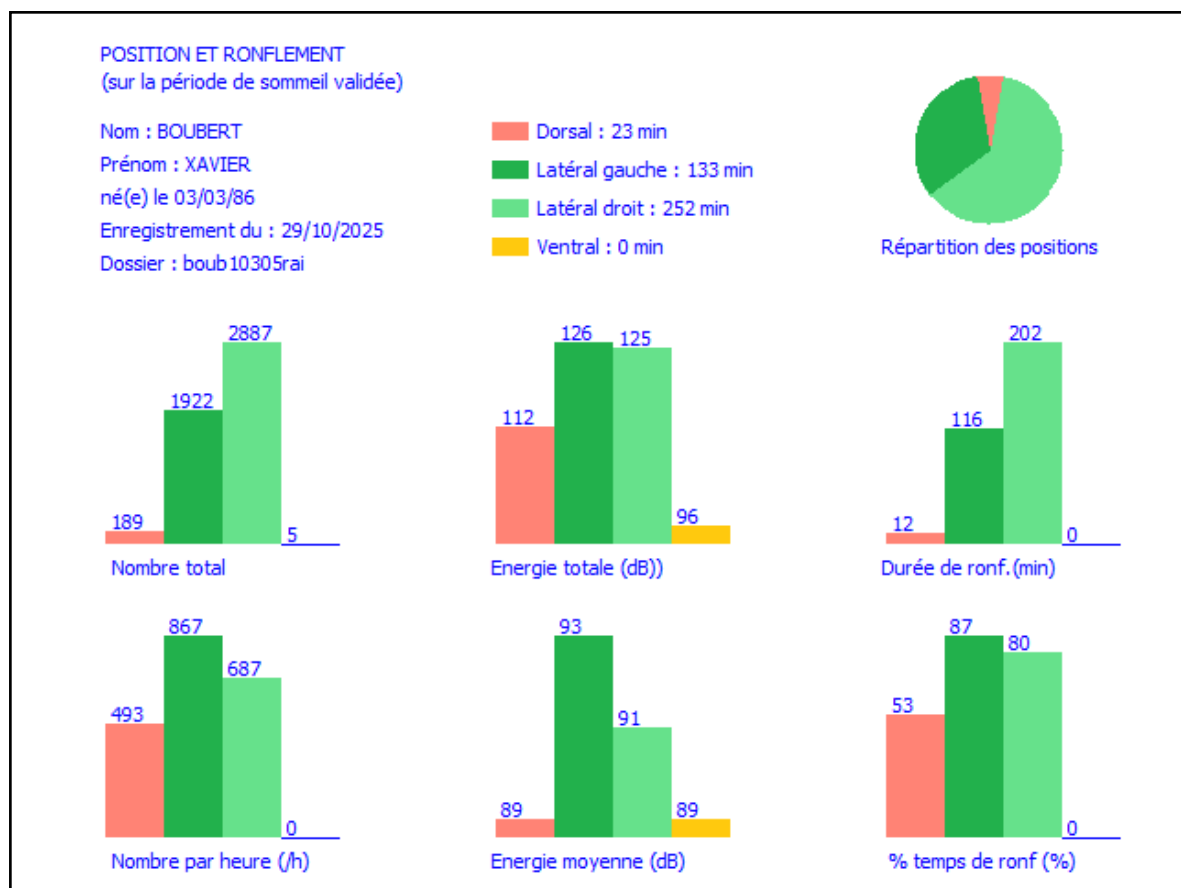
Résumé de l'enregistrement



Bilan



Histogramme de la saturation

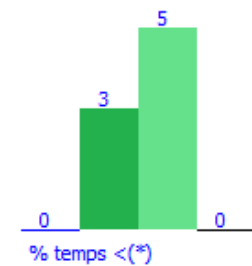
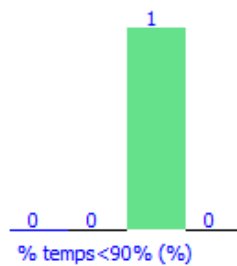
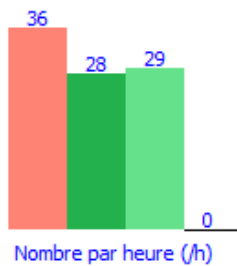
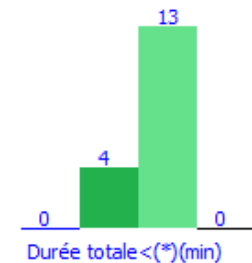
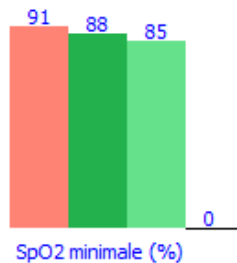
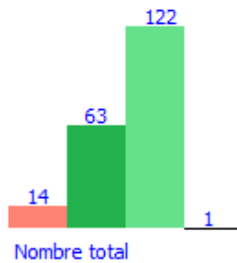


Analyse Position / Ronflements

DUREE ET NOMBRE DES DESATURATIONS EN FONCTION DE LA POSITION
(sur la période de sommeil validée)

Nom : BOUBERT
Prénom : XAVIER
né(e) le 03/03/86
Enregistrement du : 29/10/2025
Dossier : boub10305rai

Dorsal : 23 min
Latéral gauche : 133 min
Latéral droit : 252 min
Ventral : 0 min

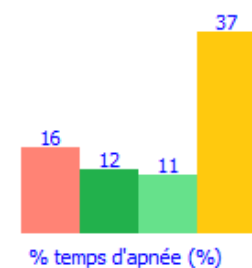
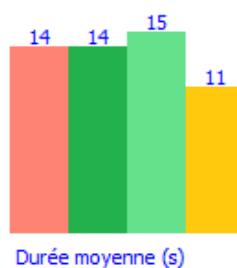
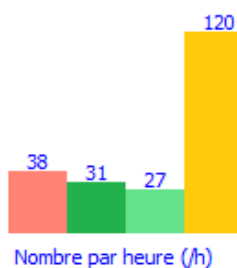
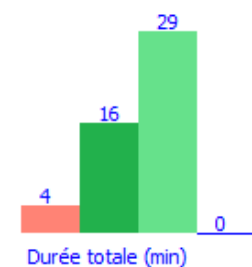
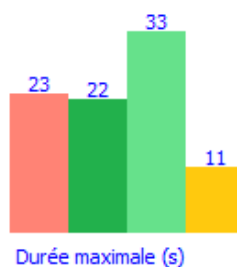
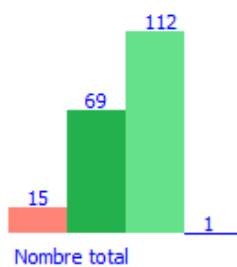


Analyse Position / Désaturations

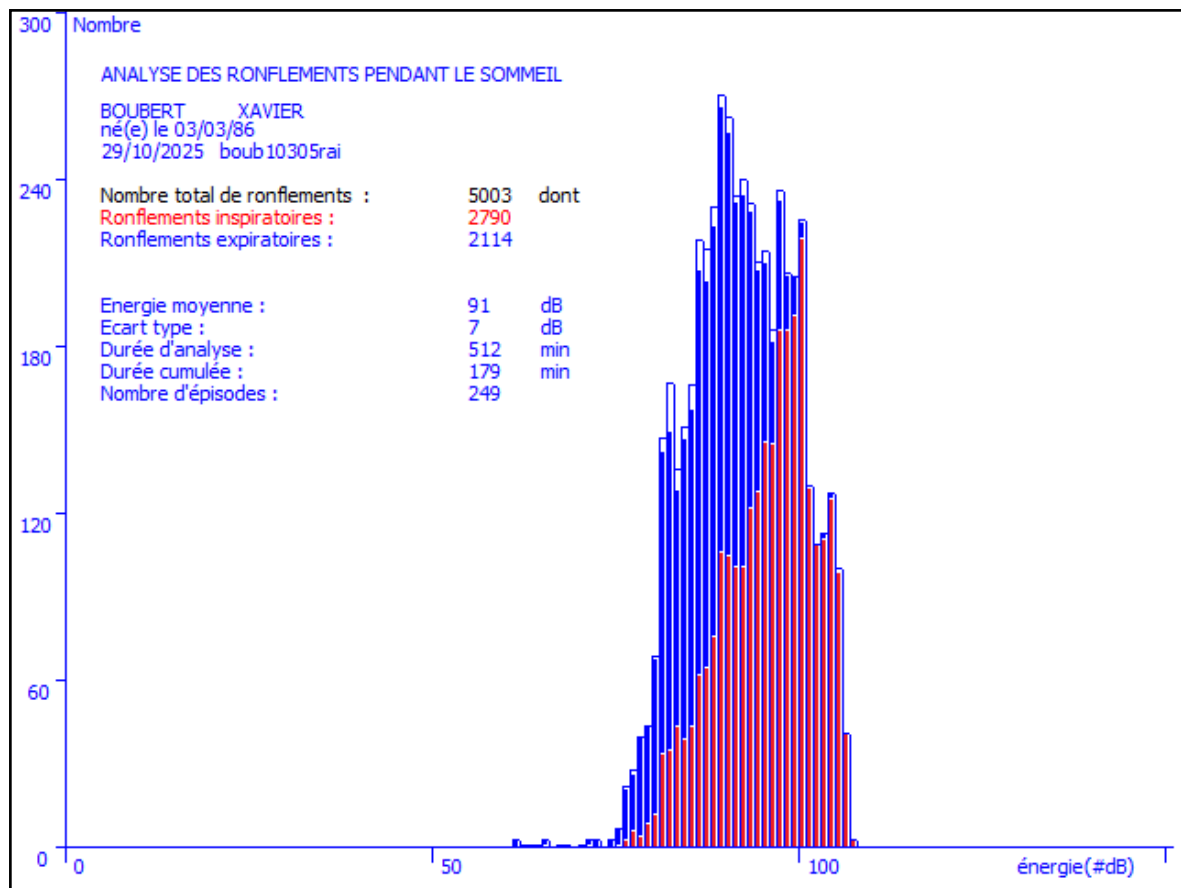
DUREES ET NOMBRES DES APNEES EN FONCTION DE LA POSITION
(sur la période de sommeil validée)

Nom : BOUBERT
Prénom : XAVIER
né(e) le 03/03/86
Enregistrement du : 29/10/2025
Dossier : boub10305rai

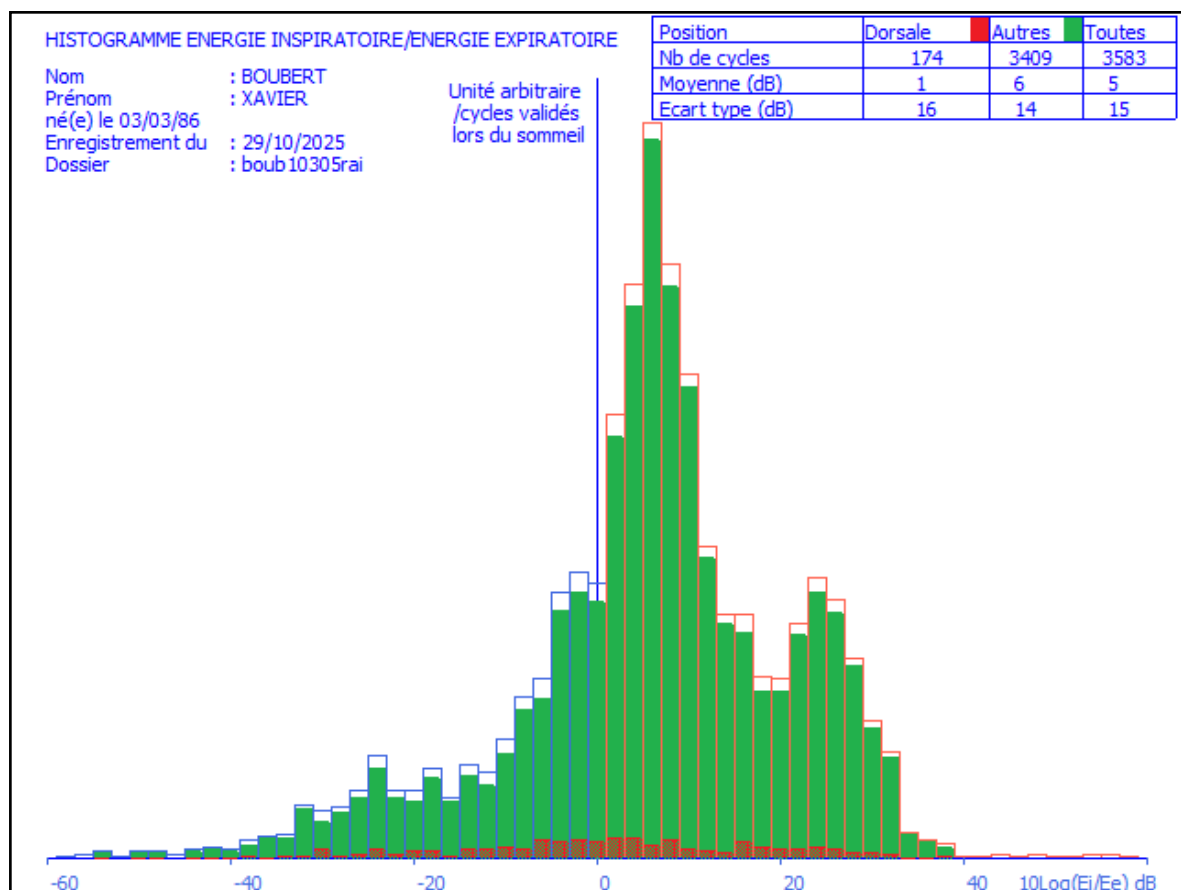
Dorsal : 23 min
Latéral gauche : 133 min
Latéral droit : 252 min
Ventral : 0 min



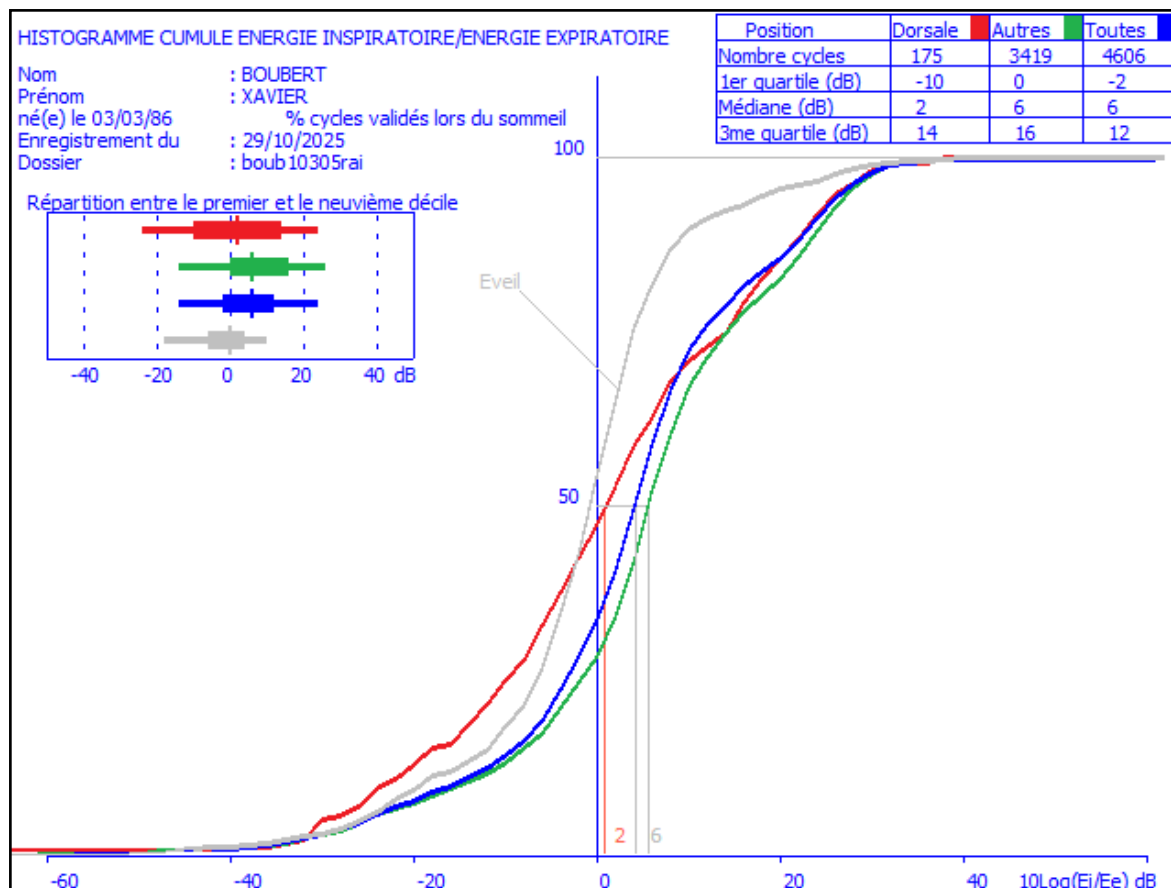
Analyse Position / Apnées



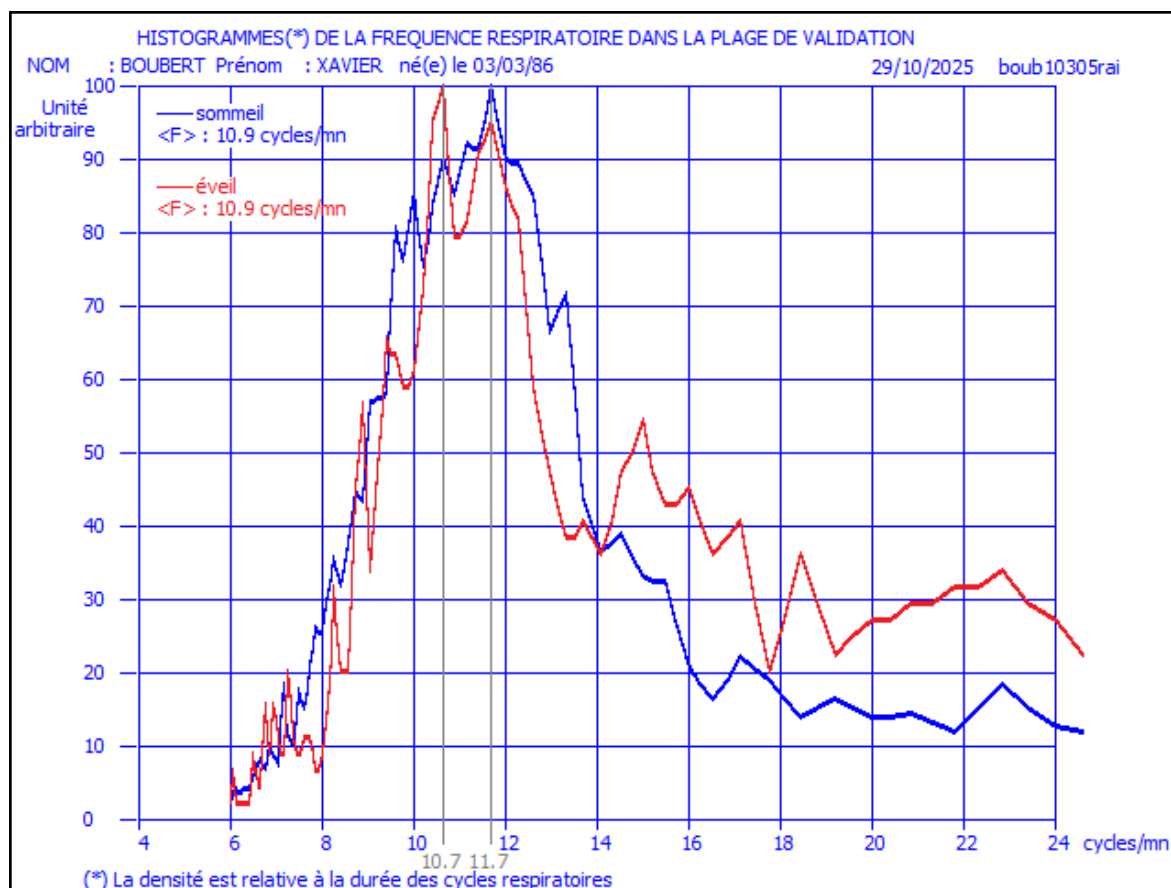
Analyse des ronflements



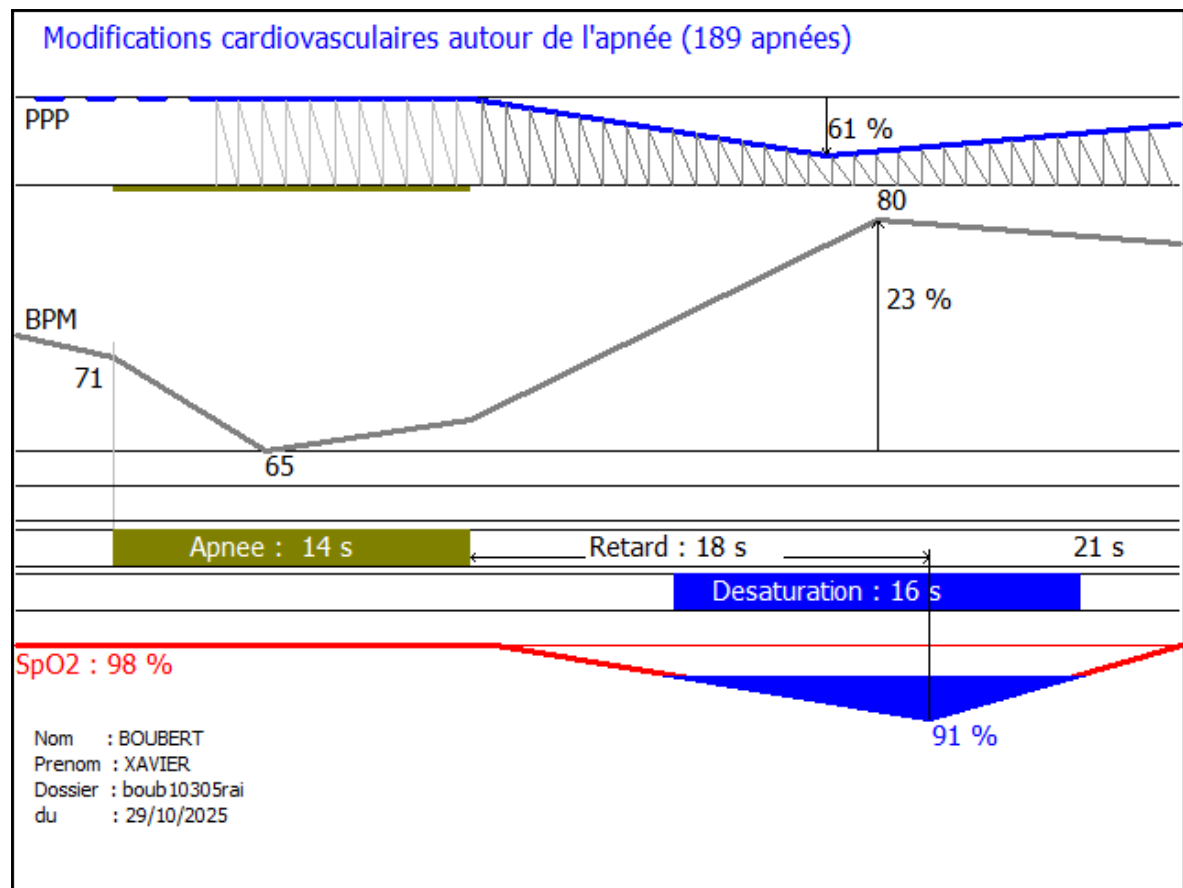
Analyse Energie inspiratoire / Energie expiratoire



Histogramme cumulé Energie inspiratoire / Energie expiratoire



Histogramme de la fréquence respiratoire



Effets cardio-vasculaires